SDD 197 Sujet n°1 sans PS ni PSS

Spécialité : Néphrologie

Date : 20/01/2025
Auteur : Renoux Noémie (DES néphrologie - EDN 2024)
Relecteur(s) : Rubin Hélène (DES néphrologie - EDN 2024), Villard Sébastien ((DES Médecine interne - EDN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostic
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de prise en charge Synthèse des résultats
Item en lien avec la station	Trouble acide bases
Situation de départ en lien avec la station	Analyse des bicarbonates
Matériel nécessaire à la station	Annexe 1 - Biologie
Contexte de la station	M. Palafrite consulte aux urgences, adressé par son médecin traitant pour des douleurs abdominales intenses non soulagées par les antalgiques de palier 1

ECOS TACFA – SUJET SANS PS NI PSS
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de garde aux Urgences.

Vous recevez M. Palafrite, un homme de 77 ans, qui consulte aux urgences pour une douleur abdominale intense (EVA = 9/10) non soulagée par les antalgiques de palier 1, associée à une contracture en fosse iliaque gauche.
M. Palafrite a pour seul antécédent une maladie diverticulaire du sigmoïde, et ne prend aucun traitement quotidien ni ponctuel.

Les paramètres vitaux sont les suivants :

- Pression artérielle : 98/30 mmHg malgré remplissage par 2 L de NaCl 0,9 %.
- Fréquence cardiaque : 105 bpm
- Saturation : 95 % en air ambiant
- Fréquence respiratoire : 25 /min
- Température : 39,1°C
- M. Palafrite est très agité, ouvre les yeux à la demande, répond de manière confuse aux questions et obéit correctement aux commandes motrices.

Le bilan biologique est le suivant :

- Natrémie : 138 mmol/l ; Kaliémie : 4,7 mmol/l ; Chlorémie : 99 mmol/l ; Créatininémie : 405 µmol/L.
- Glycémie veineuse : 5,5 mmol/l (= 1 g/l).
- Gaz du sang artériel en air ambiant : pH : 7,28 ; PaCO2 : 35 mmHg ; HCO3- : 15 mmol/l ; PaO2 : 81 mmHg ; lactate : 4,1 mmol/l

Consignes :

Vous devez :

- Interpréter la gazométrie.
- En vous aidant de l'ensemble des informations disponibles, interprétez le tableau clinique présenté par le patient et formulez une hypothèse diagnostique.

Vous ne devez pas :

- Parler à un patient simulé (station sans PS ni PSS).
- Prescrire des examens complémentaires ou des traitements.
- Rédiger d'ordonnance.

Vous avez 8 minutes.

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
Partie 1 : analyse du gaz du sang			
1.	**Décrit une acidémie <u>ET</u> le justifie au vu du pH < 7,38.**	1 pt	☐
2.	**Précise que l'acidose est métabolique <u>ET</u> le justifie car la concentration plasmatique des bicarbonates est diminuée (< 24 mmol/L)**	1 pt	☐
3.	**Explique que l'acidose est non compensée <u>ET</u> je justifie car la pCO2 est à 35 mmHg, supérieure à la valeur de 28-30 mmHg attendue.**	1 pt	☐
4.	**Décrit l'absence d'hypoxémie associée (car la PaO2 est > 80 mmHg)**	1pt	☐
5.	**Explique que le trou anionique est augmenté en utilisant l'une des deux formules suivantes :** - (Na + K) – (Cl + HCO3-) = 141 – 114 = 27 > 16 - (Na) – (Cl + HCO3-) = 138 – 114 = 24 > 12	1 pt	☐
6.	**Explique que l'excès d'acide provient probablement de l'hyperlactatémie (excès d'anions indosés).**	1pt	☐
Partie 2 : interprétation du tableau clinique et synthèse			
7.	**Calcule un score de Glasgow à 13 <u>ET</u> justifie par Y3-V4-M6**	1 pt	☐
8.	**Décrit des signes cliniques de choc <u>OU</u> d'hypoperfusion périphérique car les extrémités sont froides / TRC > 3 s / il existe des marbrures** (au moins 1 signe clinique cité)	1 pt	☐
9.	**Évoque une défaillance rénale devant l'insuffisance rénale aiguë avec une créatininémie à 405 µmol/L**	1pt	☐
10.	**Conclue à un état de choc devant** - **une PAS < 100 mmHg ne répondant pas au remplissage vasculaire (ou défaillance hémodynamique),** - **<u>ET</u> une défaillance rénale** - **<u>ET</u> une défaillance neurologique**	1 pt	☐
11.	**Formule l'hypothèse d'un choc septique sur péritonite <u>ET</u> le justifie par le syndrome infectieux et les signes d'irritation péritonéale.**	1 pt	☐
Communications et attitudes			

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL	**/13 points**